

PRD Snippet — 主動式健康關懷與用藥提醒

1. 功能定位

HomeWellness Companion 核心功能。非單一角色 Chatbot，而是共用同一套 Agent / Tool Calling / Memory 技術層，但依使用者情境提供兩種不同關係模型與對話體驗的健康陪伴系統。

2. 目標使用者與情境（雙 Persona）

	Journey Group A	Journey Group B
Persona	王阿姨	李爺爺
健康定位	亞健康 / 日常健康管理	高齡生活關懷
AI關係定位	朋友式健康夥伴	晚輩式數位陪伴者
觸發方式	IoT裝置事件（主動）	使用者聊天（被動應答）
Flow ID	iot-event-care-flow-v1	health-companion-chat-flow-v1
核心價值	將裝置數值轉化為自然生活關心	低操作門檻的生活陪伴 + 健康查詢 + 安全關懷

目前僅此兩條 Flow 有實際 Langflow 實作，皆已產出可執行的 JSON 檔案。

3. User Story

US-IOT-01（Journey Group A | 已實作於 iot-event-care-flow-v1）作為正在管理日常健康的王阿姨，當我的血壓或心率相對於平常狀態有明顯差異時，我希望健康夥伴能像朋友一樣主動問問我當時的生活情境，以便我注意身體狀況，而不需要自行分析裝置數值。

US-CHAT-01 (Journey Group B | 已實作於 health-companion-chat-flow-v1) 作為高齡使用者李爺爺，我希望能以日常聊天方式分享生活與身體狀況，以便在不操作複雜系統的情況下，獲得陪伴、資料查詢與適當提醒。

本條涵蓋「被動查詢用藥紀錄」（例：「我早上的藥有吃嗎」→呼叫 GET_MEDICATION_RECORD），此為 health-companion-chat-flow-v1 已支援的情境。

US-MED-01 (不經 AI Agent / 由 App 端處理) 作為長者，當我忘記服藥或時間到未確認服藥時，我希望系統能主動提醒我，而不需要我自己記得。

狀態說明：此項不需要、也不會走 Langflow。 用藥提醒的時間觸發與通知，設計上由 App 端本地機制（本地計時器 + 通知）直接完成，不需經過 AI Agent 判斷或生成——這不是實作缺口，是架構上刻意的職責劃分：AI Agent 負責「理解與對話」，時間排程與提醒屬 App 的本地職責，兩者不必要耦合。李爺爺後續若想追問用藥細節（例如「我今天的藥吃了嗎」），才會進入 US-CHAT-01 既有的查詢路徑，呼叫 GET_MEDICATION_RECORD。

4. 觸發條件與資料流（精簡版）

Journey	觸發	資料/判斷邏輯	產出動作	實作/歸屬
A：亞健康主動關懷	裝置量測血壓/心率	與王阿姨個人基準值比較（非單一人口學絕對門檻），分類為 high_bp_high_relative_hr / 偏高單項 / 無顯著變化	AI主動發起對話，先問生活情境（活動/疲勞/壓力/休息），非直接判斷疾病	已實作（Langflow）
B：聊天式陪伴（含被動查藥）	李爺爺主動開啟對話	依語意判斷是否需查詢工具（GET_CURRENT_VITALS / GET_MEDICATION_RECORD / GET_SLEEP_HISTORY）	先回應生活情境，需要時才查資料；高風險症狀（胸痛/喘不過氣）建議尋求真人協助	已實作（Langflow）
用藥主動提醒	時間到未確認服藥	App 本地讀取用藥排程	App 本地通知提醒，不經 AI Agent	架構上不需 Langflow，由 App 端處理

註1: Journey A 目前規劃採「相對個人基準」判斷（非固定閾值），與既有 AWS IoT Rule Engine 規格中「收縮壓>140命中高血壓Rule」的絕對閾值設計方向不同，兩者需要對齊，屬待處理項目，不在本 PRD Snippet 範圍內展開。註2: 用藥主動提醒在 Demo 中可直接說明其為 App 本地功能、非 AI Agent 職責範圍，不涉及 Langflow，屬正常架構分工，非未完成項目。

5. PRD 規格重點 (Acceptance-oriented)

- Agent 能依語意判斷是否需呼叫 Tool 查詢即時數據，不重複查詢已在對話上下文中的資訊
- Agent 能記住歷史健康狀況與用藥紀錄 (Memory)，不重複提醒已服用項目
- Journey A 的主動關懷由裝置事件觸發，非使用者需先開口；判斷基準為個人相對變化，非單一絕對數值
- Journey B 以聊天為主入口，先回應生活內容，僅在語意觸發時才連結健康資料查詢（含被動查詢用藥紀錄）
- 用藥「主動提醒」（時間觸發）由 App 端本地機制處理，不經 AI Agent，屬架構上刻意的職責劃分，非缺口
- 高風險症狀（如胸痛、喘不過氣）不由 Agent 自行判斷處置，導向真人/醫療協助
- 兩條已實作 Journey 共用同一套 Agent / Tool Calling / Memory 技術層，僅 Persona、語氣、主動性策略不同

6. Vibe / 語氣設計原則

Journey A (王阿姨 · 朋友式)

- 平等語氣，不使用照護式或哄長輩式用語
- 先了解近期活動 / 壓力 / 休息，再談數值
- 不將單次數值直接定義為疾病，不使用「異常」「警告」等系統性詞彙
- 一次只問一個主要問題
- 避免：孫輩稱謂、高齡照護口吻、醫療警告式通知、每次都要求聯絡家人

Journey B (李爺爺 · 晚輩式陪伴)

- 尊重語氣（「您」「李爺爺」），語句簡單清楚，避免同時問多個問題
- 先聽生活，再談健康；不假裝是真正的家人，但對話可有熟悉晚輩的溫度
- 服藥與高風險症狀採較嚴格的安全邊界，適度建議尋求家人協助
- 避免：過度幼兒化、冷冰冰客服語氣、只重視數值不理會生活內容

7. Out of Scope

- 不涉及醫療診斷、不提供治療建議或劑量調整
- 不做真實緊急通報串接（119 / 簡訊 / 醫院 / 照護中心）
- Memory 不等於完整電子病歷（EMR）系統
- 高風險症狀僅止於「建議尋求真人與醫療協助」，不由 Agent 做進一步醫療判斷
- 用藥主動提醒（時間觸發）由 App 本地機制處理，不經 AI Agent，非 Langflow 涵蓋範圍，屬架構分工非缺口